BONUS 1

Banka 200 závěrů popisu

200 hotových vět pro Závěr / Souhrn seřazených podle modalit a systémů pro normální vyšetření, incidentální a akutní nálezy. Uzavřete svůj popis jednou jasnou větou, díky níž bude čtenář přesně vědět, co dělat.

Obsah

Jak psát závěr popisu

RTG — 50 vět

CT — 70 vět

MR — 35 vět

UZ / Doppler — 45 vět

Další krok

ÚVODEM

Jak psát závěr popisu

Krok SHRŇTE: odpověď na klinickou otázku, nejdůležitější nález na prvním místě, v případě potřeby doporučení a hlášení.

> *Většina kliniků čte nejdříve Závěr. I kdyby byl popis nálezů sebelépe zpracovaný, pokud je Závěr nejednoznačný, popis zůstává nekompletní.*

1. **Nejprve odpovězte na klinickou otázku** — pokud zněla otázka «apendicitida?», v první větě musí být uvedeno, zda je apendicitida přítomna, či nikoli.
2. **Seřaďte podle důležitosti** — urgentní nález je vždy na prvním místě; incidentální nálezy na samém konci.
3. **Neopakujte nálezy, interpretujte je** — Závěr není kopií Nálezů, nýbrž jejich významem.
4. **Doporučení formulujte konkrétně** — místo «doporučeno další došetření» uveďte, jaké vyšetření a proč.
5. **U urgentního nálezu zaznamenejte hlášení** — komu, v kolik hodin a jakým způsobem byl nahlášen.

Typy vět

ŠTÍTEK	KDY	V TÉTO BANCE
V NORMĚ	Bez patologie nebo beze změn; limity hodnocení.	43 vět
NÁLEZ	Běžné nálezy ve vztahu ke klinické otázce.	82 vět
INCIDENTÁLNÍ	Náhodný nález; s doporučením obecné korelace nebo sledování.	26 vět
AKUTNÍ	Nález vyžadující okamžité hlášení; se záznamem o nahlášení.	49 vět

O kontrolních intervalech

Ve formulacích incidentálních nálezů není uveden interval sledování ani prahová velikost. Sledování uzlů, lézí nadledvin, cyst a podobných nálezů se řídí rizikovým profilem pacienta a aktuálními doporučenými postupy vašeho pracoviště; neuvádějte do popisu číslo, kterým si nejste jisti, zeptejte se svého školitele.

Hranaté závorky

[vpravo/vlevo], [.. mm], [hodin] doplňte tato pole a nehodící se možnosti smažte. V popisu nesmí zůstat žádné hranaté závorky.

KAPITOLA 1

RTG

50 závěrů popisu podle systémů.

RTG · Hrudník

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
001	Na RTG hrudníku nebyla zjištěna akutní kardiopulmonální patologie.	V NORMĚ
002	Ve srovnání s předchozím vyšetřením bez zřetelné změny.	V NORMĚ
003	Na lůžkovém snímku bez nově vzniklých opacit, výpotku či pneumotoraxu.	V NORMĚ
004	Kanyly a katétry ve správné poloze; bez známek iatrogenních komplikací.	V NORMĚ
005	[Vpravo/Vlevo] [lalok] konsolidace; v klinickém kontextu může odpovídat pneumonii.	NÁLEZ
006	Ve srovnání s předchozím vyšetřením [pravá dolní zóna] výrazná regrese konsolidace.	NÁLEZ
007	Ve srovnání s předchozím vyšetřením [pravá dolní zóna] progrese konsolidace; doporučena klinická korelace.	NÁLEZ
008	[Vpravo/Vlevo] [malé/střední/velké množství] množství pleurálního výpotku.	NÁLEZ
009	Oboustranně malé množství pleurálního výpotku a bazální pasivní atelektáza.	NÁLEZ
010	[Vpravo/Vlevo] [lalok] atelektáza; k vyloučení centrální obstrukční příčiny v případě potřeby doporučeno CT.	NÁLEZ
011	Bazálně lineární (deskovité) atelektázy.	NÁLEZ
012	Kardiomegalie (na PA snímku).	NÁLEZ
013	Vzhledem k AP projekci je hodnocení velikosti srdce limitované.	NÁLEZ
014	Nález svědčící pro plicní edém; doporučena klinická korelace.	NÁLEZ
015	Známky plicní venózní kongesce.	NÁLEZ
016	Ve srovnání s předchozím vyšetřením regrese známek plicního edému.	NÁLEZ
017	[Vpravo/Vlevo] plíce [zóna] v [.. mm] expanzivní léze; doporučeno CT hrudníku s kontrastní látkou.	NÁLEZ
018	[Vpravo/Vlevo] [zóna] kavitující léze; doporučena klinická korelace a CT k posouzení infekčních procesů a neoplazie.	NÁLEZ
019	Oboustranně mnohočetná milimetrová nodulární zastínění (miliární obraz); doporučena klinická a mikrobiologická korelace.	NÁLEZ
020	Známky hyperinflace; mohou odpovídat CHOPN.	NÁLEZ

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
021	[Vpravo/Vlevo] [..]. žebro: fraktura; pneumotorax nezastižen.	NÁLEZ
022	Konec endotracheální kanyly od kariny [.. cm] nad ním, ve správné poloze.	NÁLEZ
023	Hrot centrálního žilního katétru v projekci horní duté žíly; pneumotorax nezastižen.	NÁLEZ
024	[Vpravo/Vlevo] [zóna] v [.. mm] nodulární zastínění; k bližší charakterizaci doporučena klinická korelace a v případě potřeby CT.	INCIDENTÁLNÍ
025	Kalzifikované ateromatózní změny na aortě.	INCIDENTÁLNÍ
026	[Vpravo/Vlevo] pneumotorax. Ošetřujícímu týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
027	[Vpravo/Vlevo] rozsáhlý pneumotorax a radiologické známky tenze. Urgentní nález; [hodin] telefonicky nahlášeno.	AKUTNÍ
028	Konec endotracheální kanyly [pravý hlavní bronchus] v projekci. Ošetřujícímu týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
029	Konec nazogastrické sondy [pravý hlavní bronchus] v projekci, není ve správné poloze; před použitím [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
030	Výrazné rozšíření mediastina; při traumatu nebo bolesti na hrudi doporučena urgentní CT angiografie k vyloučení patologie aorty. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

RTG · Břicho

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
031	Na nativním RTG břicha bez známek obstrukce či volného plynu.	V NORMĚ
032	Distribuce střevního plynu je obvyklá.	V NORMĚ
033	Nález svědčící pro obstrukci tenkého střeva; doporučeno kontrastní CT břicha.	NÁLEZ
034	Výrazná sterkorální náplň v tračníku.	NÁLEZ
035	[Vpravo/Vlevo] [lokalizace] v projekci denzita podezřelá z rentgenkontrastního konkrementu; doporučena korelace s UZ nebo nativním CT.	NÁLEZ
036	Kalcifikované denzity v pánvi, jež mohou odpovídat flebolitům.	INCIDENTÁLNÍ
037	Volný plyn pod bránicí (pneumoperitoneum). Urgentní nález; klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
038	Nález svědčí pro volvulus sigmatu. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ

RTG · Muskuloskeletální

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
039	[Vpravo/Vlevo] [oblast] nebyla zjištěna akutní kostní patologie.	V NORMĚ
040	Bez známek fraktury či luxace; kloubní štěrbiny jsou zachovány.	V NORMĚ

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
041	Linie lomu nepatrná; při přetrvávajícím klinickém podezření nelze okultní frakturu na RTG snímku vyloučit.	V NORMĚ
042	[Vpravo/Vlevo] fraktura distálního radia ([intraartikulární/extraartikulární], [dorzální] se sklonem).	NÁLEZ
043	[Vpravo/Vlevo] skafoid [bederní páteř] fraktura.	NÁLEZ
044	[Vpravo/Vlevo] [anteriorní] glenohumerální luxace; doporučen kontrolní snímek po repozici.	NÁLEZ
045	[Vpravo/Vlevo] [laterální kotník] fraktura; vidlice [zachovaný/rozšířený].	NÁLEZ
046	Postavení úlomků po repozici fraktury [akceptovatelný/narušený].	NÁLEZ
047	[Vpravo/Vlevo] degenerativní změny kolene (osteoartróza); bez akutní kostní patologie.	NÁLEZ
048	Příznak zadního tukového polštářku; doporučeno ortopedické zhodnocení k vyloučení okultní fraktury.	NÁLEZ
049	[Kost] v [.. mm] lytická léze; k bližší charakterizaci doporučena klinická korelace a doplňující vyšetření.	INCIDENTÁLNÍ
050	[Vpravo/Vlevo] fraktura krčku femuru ([dislokovaný/nedislokovaný]). Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ

KAPITOLA 2

CT

70 závěrů popisu podle systémů.

CT · Neuroradiologie

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
051	Na nativním CT mozku neprokázána akutní intrakraniální patologie.	V NORMĚ
052	Bez intrakraniálního krvácení, expanzivních projevů či přetlaku středočárových struktur.	V NORMĚ
053	Časná ischemická cévní mozková příhoda nemusí být na nativním CT patrná; při přetrvávajícím klinickém podezření lze zvážit DWI MR.	V NORMĚ
054	Ve srovnání s předchozím vyšetřením bez nového krvácení či nárůstu expanzivních projevů.	V NORMĚ
055	Mozková atrofie přiměřená věku; bez akutní patologie.	V NORMĚ
056	Periventrikulární hypodenzity, jež mohou odpovídat chronickému onemocnění malých cév.	NÁLEZ
057	[Vpravo/Vlevo] [lokalizace] ložisko encefalomalacie odpovídající chronickému infarktu.	NÁLEZ
058	[Vpravo/Vlevo] [lalok] expanzivní léze a vazogenní edém; doporučeno MR mozku s kontrastní látkou.	NÁLEZ
059	[Lokalizace] nález odpovídající sinusitidě.	NÁLEZ
060	[Vpravo/Vlevo] [kost] lineární fraktura; bez doprovodného intrakraniálního krvácení.	NÁLEZ
061	[Lokalizace] extraaxiální léze s kalcifikacemi; může odpovídat meningeomu, doporučena korelace s MR.	INCIDENTÁLNÍ
062	[Lokalizace] léze v denzitě likvoru, která může odpovídat arachnoidální cystě.	INCIDENTÁLNÍ
063	[Vpravo/Vlevo] akutní epidurální hematom; [.. mm] přesun středočarových struktur. Urgentní nález; ošetřujícímu týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
064	[Vpravo/Vlevo] akutní subdurální hematom; přítomen expanzivní efekt. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
065	Subarachnoidální krvácení; k vyloučení aneuryzmatu doporučena CT angiografie. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
066	[Vpravo/Vlevo] [lokalizace] akutní intraparenchymový hematom, provalení do komor [přítomno/nepřítomno]. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
067	[Vpravo/Vlevo] Známky časné akutní ischémie v povodí ACM; bez hemoragie. V rámci iktového protokolu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
068	[Vpravo/Vlevo] Příznak hyperdenzní arterie v ACM; může svědčit pro akutní trombus, doporučena CT angiografie. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
069	Nález svědčící pro akutní obstrukční hydrocefalus. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
070	[Subfalcinní/Transtentoriální/Tonsilární] známky herniace. Urgentní nález; [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
071	[Vpravo/Vlevo] [kost] impresivní fraktura a pod ní [extraaxiální krvácení]. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
072	Na CT angiografii [vpravo/vlevo] [MCA M1] okluze v segmentu. V rámci iktového protokolu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ

CT · Hrudník

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
073	Na CT hrudníku bez signifikantní patologie.	V NORMĚ
074	Na CT plicní angiografii nebyla prokázána plicní embolie.	V NORMĚ
075	Pro nedostatečnou opacifikaci plicních tepen je hodnocení na subsegmentální úrovni limitované.	V NORMĚ
076	[Vpravo/Vlevo] [lalok] konsolidace; může odpovídat infekčnímu procesu.	NÁLEZ
077	Oboustranně denzity mléčného skla; v diferenciální diagnostice přicházejí v úvahu infekční a zánětlivé procesy, doporučena klinická korelace.	NÁLEZ
078	[Centrilobulární] emfyzém.	NÁLEZ
079	Lymfatické uzliny patologické velikosti v mediastinu; nutno hodnotit v klinickém kontextu.	NÁLEZ
080	[Vpravo/Vlevo] v plíci [.. mm] expanzivní léze a [hilový/mediastinální] lymfadenopatie; doporučeno klinické zhodnocení k bioptické verifikaci.	NÁLEZ
081	[Vpravo/Vlevo] [lalok] v [.. mm] [solidní] uzel; nutnost sledování je třeba stanovit podle rizikového profilu a platných doporučení ve spolupráci s ošetřujícím týmem.	INCIDENTÁLNÍ
082	Kalcifikace v koronárních tepnách.	INCIDENTÁLNÍ
083	Štítná žláza [vpravo/vlevo] v laloku hypodenzní uzel; doporučeno dovyšetření pomocí UZ.	INCIDENTÁLNÍ
084	[Bilaterální] akutní plicní embolie; známky přetížení pravé komory [přítomno/nepřítomno]. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ
085	[Postihující/nepostihující vzestupnou aortu] disekce aorty. Akutní nález; klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
086	[Vpravo/Vlevo] pneumotorax. Ošetřujícímu týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
087	Pneumomediastinum; při klinickém podezření na perforaci jícnu doporučeno dovyšetření. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ
088	[Střední/Velké množství] množství perikardiálního výpotku; doporučeno urgentní klinické a echokardiografické zhodnocení k vyloučení tamponády. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

CT · Břicho a pánev

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
089	Na CT břicha a pánve nebyla zjištěna akutní patologie.	V NORMĚ
090	Apendix normálního vzhledu; bez známek akutní apendicitidy.	V NORMĚ
091	Na nativním CT neprokázána urolitiáza ani hydronefróza.	V NORMĚ
092	Ve srovnání s předchozím vyšetřením [léze] beze zřetelných změn.	V NORMĚ
093	[Sigmoideum] akutní nekomplikovaná divertikulitida tračníku.	NÁLEZ
094	[Vpravo/Vlevo] [distální] v močovodu [.. mm] konkrement a [mírný] hydroureteronefróza.	NÁLEZ
095	Akutní [intersticiální edematózní] známky pankreatitidy.	NÁLEZ
096	Nález svědčící pro akutní cholecystitidu; doporučena korelace s UZ.	NÁLEZ
097	Cholecystolitiáza; známky akutní cholecystitidy neprokázány.	NÁLEZ
098	Četná jaterní ložiska, jež mohou odpovídat metastázám; doporučena klinická a v případě potřeby histopatologická korelace.	NÁLEZ
099	Hepatosteatóza.	NÁLEZ
100	[Malé/Střední množství] množství ascitu.	NÁLEZ
101	[Lokalizace] zesílení stěny tračníku; diferenciální diagnóza zahrnuje zánětlivé, infekční a neoplastické příčiny, doporučena endoskopická korelace.	NÁLEZ
102	Jaterní segment [..]: léze odpovídající prosté cystě.	INCIDENTÁLNÍ
103	[Vpravo/Vlevo] léze v ledvině odpovídající prosté cystě.	INCIDENTÁLNÍ
104	[Vpravo/Vlevo] uzel nadledviny; charakterizaci a sledování je třeba stanovit ve spolupráci s klinickým týmem dle platných doporučených postupů.	INCIDENTÁLNÍ
105	[Vpravo/Vlevo] v ledvině [.. mm] blíže necharakterizovatelná léze; k dalšímu dovyšetření [dynamické CT/MR] doporučeno.	INCIDENTÁLNÍ
106	V játrech při tomto vyšetření blíže necharakterizovatelná/é [.. mm] hypodenzní léze; v případě potřeby doporučeno dovyšetření dynamickým MR.	INCIDENTÁLNÍ
107	Nález svědčící pro akutní apendicitidu. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
108	Akutní apendicitida a [periapendikulární absces/perforace] známky. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ
109	Pneumoperitoneum; [možná lokalizace] svědčící pro perforaci. Urgentní nález; [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
110	Tranzitní zóna [oblast] známky svědčící pro mechanickou obstrukci tenkého střeva a ischemii. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ
111	Aneurysma břišní aorty a periaortální hematom svědčící pro rupturu. Urgentní nález; [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
112	Poranění sleziny, hemoperitoneum a aktivní extravazace kontrastní látky. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ
113	Pneumatóza střevní stěny a plyn v portální žíle; z hlediska mezenteriální ischemie je doporučeno urgentní klinické zhodnocení. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ
114	[Vpravo/Vlevo] obstrukční konkrement v močovodu a [perirenální kolekce/emfyzematózní změny]; při klinickém podezření na infikovanou obstrukci je doporučeno urgentní došetření. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

CT · Páteř a muskuloskeletální systém

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
115	Na CT krční páteře bez známek akutní traumatické kostní patologie.	V NORMĚ
116	Ligamentózní poranění nelze na CT zcela vyloučit; při neurologické symptomatologii doporučena MR.	V NORMĚ
117	[L1] na obratli kompresivní fraktura akutního vzhledu; bez zúžení páteřního kanálu.	NÁLEZ
118	Degenerativní změny bederních obratlů.	NÁLEZ
119	[Obratel] sklerotické ložisko v těle; může odpovídat kostnímu ostrůvku, doporučena klinická korelace.	INCIDENTÁLNÍ
120	[Úroveň] v úrovni obraz instabilní fraktury/luxace a zúžení páteřního kanálu. Urgentní nález; [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ

KAPITOLA 3

MR

35 závěrů popisu podle systémů.

MR · Neuroradiologie

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
121	Na MR mozku nebyla zjištěna signifikantní patologie.	V NORMĚ
122	Na DWI bez restrikce difuze svědčící pro akutní infarkt.	V NORMĚ
123	Po podání kontrastní látky nebylo patrné patologické sycení.	V NORMĚ
124	Ve srovnání s předchozím vyšetřením bez nových či sytících se lézí.	V NORMĚ
125	Změny bílé hmoty, jež mohou odpovídat chronickému onemocnění malých cév; bez známek akutního infarktu.	NÁLEZ
126	Léze bílé hmoty, které mohou odpovídat demyelinizačnímu onemocnění; nutno hodnotit v korelaci s klinikou a platnými diagnostickými kritérii.	NÁLEZ
127	[Oblast] extraaxiální expanze imponující jako meningeom.	NÁLEZ
128	Hypofýza [mikro/makro] léze odpovídající adenomu; doporučena endokrinologická korelace.	NÁLEZ
129	[Vpravo/Vlevo] [lalok] prstencovitě se sytící intraaxiální expanze; v diferenciální diagnóze přichází v úvahu především high-grade gliom a metastáza.	NÁLEZ
130	Cystická léze, jež může odpovídat pineální cystě.	INCIDENTÁLNÍ
131	[Lokalizace] obraz odpovídající vývojové žilní anomálii (DVA).	INCIDENTÁLNÍ
132	[Vpravo/Vlevo] [tepna] akutní infarkt v povodí. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
133	Nález svědčící pro mozkový absces. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
134	[Sinus] trombóza. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
135	Akutní hemoragie v lézi hypofýzy s útlakem chiazma opticum; doporučeno urgentní klinické zhodnocení k vyloučení apoplexie. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

MR · Páteř

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
136	Na MR bederní páteře zjištěna významná patologie.	V NORMĚ
137	Kromě diskopatie bez známek významné komprese.	V NORMĚ

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
138	L [4-5] [pravý paramediální] extruze disku; [L5] komprese nervového kořene.	NÁLEZ
139	C [5-6] komplex disk-osteofyt a [vpravo] foraminální stenóza; mícha bez signálových změn.	NÁLEZ
140	[L1] na obratli [akutní/subakutní] kompresivní fraktura; bez známek svědčících pro patologickou frakturu.	NÁLEZ
141	[Obratel] v těle léze odpovídající typickému hemangiomu.	INCIDENTÁLNÍ
142	[Úroveň] v úrovni léze podezřelá z epidurálního nádorového šíření a komprese míchy. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ
143	[Úroveň] v úrovni velká extruze disku s výraznou kompresí kořenů cauda equina; doporučeno urgentní zhodnocení v korelaci s klinickým stavem. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

MR · Muskuloskeletální

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
144	[Vpravo/Vlevo] Na MR kolene nebyla zjištěna žádná signifikantní patologie.	V NORMĚ
145	[V plné tloušťce] ruptura LCA a [laterální kompartment] kostní kontuze.	NÁLEZ
146	[Mediální] meniskus [zadní roh] [šikmý] ruptura.	NÁLEZ
147	Ve šlaše musculus supraspinatus [v plné tloušťce / transmurální] ruptura; retrakce [.. mm].	NÁLEZ
148	[Vpravo/Vlevo] avaskulární nekróza hlavice femuru; bez kolapsu kloubního povrchu.	NÁLEZ
149	Popliteální (Bakerova) cysta; bez známek ruptury.	NÁLEZ
150	[Oblast] postižení kostní dřeně v a [subperiostální/měkkotkáňový] kolekce; doporučeno urgentní klinické zhodnocení k vyloučení osteomyelitidy a abscesu. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

MR · Břicho a pánev

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
151	Na dynamickém MR jater nebyla nalezena ložisková léze.	V NORMĚ
152	Jaterní segment [..]: léze odpovídající typickému hemangiomu.	NÁLEZ
153	Konkrement v distálním choledochu (choledocholitiáza) a dilatace žlučových cest.	NÁLEZ
154	[Vpravo/Vlevo] v ovariu léze odpovídající prosté cystě; nutnost sledování musí stanovit ošetřující tým.	INCIDENTÁLNÍ
155	V pankreatu [.. mm] cystická léze; charakterizaci a sledování je třeba stanovit podle platných doporučení ve spolupráci s ošetřujícím týmem.	INCIDENTÁLNÍ

KAPITOLA 4

UZ / Doppler

45 závěrů popisu podle systémů.

UZ / Doppler · Břicho

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
156	Na UZ celého břicha bez patologického nálezu.	V NORMĚ
157	Žlučník v normě; bez známek litiázy či akutní cholecystitidy.	V NORMĚ
158	Intrahepatické ani extrahepatické žlučové cesty nejsou dilatované.	V NORMĚ
159	V břišní dutině nebyla prokázána volná tekutina.	V NORMĚ
160	Hodnocení pankreatu je limitováno střevním plynem.	V NORMĚ
161	Cholecystolitiáza; známky akutní cholecystitidy neprokázány.	NÁLEZ
162	Žlučový kal (sludge) ve žlučníku.	NÁLEZ
163	[Mírný/Střední/Výrazný] obraz odpovídající steatóze jater.	NÁLEZ
164	Hrubší echotextura a nodulární kontura, jež mohou odpovídat chronickému parenchymatóznímu onemocnění jater.	NÁLEZ
165	Splenomegalie.	NÁLEZ
166	Dilatace choledochu; pokud nebyla zjištěna příčina, doporučuje se MRCP.	NÁLEZ
167	[Malé/Střední/Velké množství] množství ascitu.	NÁLEZ
168	Jaterní segment [..]: hyperechogenní léze, která může odpovídat hemangiomu; dle klinického kontextu se doporučuje dovyšetření.	INCIDENTÁLNÍ
169	Ve žlučníku [.. mm] polyp; nutnost sledování je třeba stanovit podle platných doporučení.	INCIDENTÁLNÍ
170	Nález svědčící pro akutní litiatickou cholecystitidu. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
171	Nález svědčící pro akutní apendicitidu. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
172	[Ileokolický] známky odpovídající invaginaci. Urgentní nález; [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
173	Jaterní segment [..]: léze, která může odpovídat abscesu. Klinickému týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ

UZ / Doppler · Urogenitální trakt a pánev

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
174	Při UZ močového traktu bez patologického nálezu.	V NORMĚ
175	Na dopplerovském UZ skrota bilaterálně symetrický testikulární průtok; patologie nezastižena.	V NORMĚ
176	[Vpravo/Vlevo] [mírný/střední] hydronefróza; [možná příčina].	NÁLEZ
177	[Vpravo/Vlevo] v ledvině [.. mm] konkrement; bez hydronefrózy.	NÁLEZ
178	[Vpravo/Vlevo] známky odpovídající epididymo-orchitidě; testikulární perfuze zachována.	NÁLEZ
179	[Vpravo/Vlevo] prostá kortikální cysta ledviny.	INCIDENTÁLNÍ
180	Prostata [zvětšený]; doporučena klinická korelace.	INCIDENTÁLNÍ
181	[Vpravo/Vlevo] nález svědčící pro torzi varlete. Urgentní nález; [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
182	Intrauterinní těhotenství nezastiženo; adnexální expanze s volnou tekutinou svědčí pro ektopickou graviditu. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

UZ / Doppler · Cévní

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
183	[Vpravo/Vlevo] v hlubokých žilách dolních končetin nebyla zjištěna trombóza.	V NORMĚ
184	V karotických tepnách oboustranně bez známek hemodynamicky významné stenózy.	V NORMĚ
185	[Vpravo/Vlevo] [arteria carotis interna] aterosklerotický plát v tepně; stupeň stenózy dle kritérií pracoviště [stupeň].	NÁLEZ
186	[Vpravo/Vlevo] nález svědčící pro povrchovou žilní trombózu; hluboký žilní systém je průchodný.	NÁLEZ
187	Ve srovnání s předchozím vyšetřením v trombu [rekanalizace/beze změn].	NÁLEZ
188	V infrarenální břišní aortě [.. mm] dilatace; nutnost sledování je třeba stanovit ve spolupráci s ošetřujícím týmem.	INCIDENTÁLNÍ
189	[Vpravo/Vlevo] [femoropopliteální] akutní hluboká žilní trombóza v segmentu. Ošetřujícímu týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
190	U symptomatického pacienta [.. mm] aneuryzma břišní aorty; rupturu nelze na UZ vyloučit, doporučena urgentní CT angiografie. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

UZ / Doppler · Krk a povrchové tkáně

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
191	Na UZ štítné žlázy bez patologického nálezu.	V NORMĚ

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
192	Na krku nebyly zjištěny lymfatické uzliny patologického vzhledu.	V NORMĚ
193	Štítná žláza [pravý lalok] v [.. mm] uzel; podle stratifikace rizika vašeho pracoviště [kategorie].	NÁLEZ
194	Heterogenní echotextura, která může odpovídat difuznímu onemocnění štítné žlázy; doporučena korelace s funkčními testy štítné žlázy.	NÁLEZ
195	[Oblast] kolekce odpovídající abscesu měkkých tkání a známky perifokální celulitidy.	NÁLEZ
196	[Vpravo/Vlevo] léze prsu odpovídající prosté cystě.	INCIDENTÁLNÍ

UZ / Doppler · POCUS a eFAST

Č.	ZÁVĚR / RESUMÉ	TYP
197	Při eFAST nezjištěny známky volné tekutiny, perikardiálního výpotku ani pneumotoraxu. Negativní eFAST nevylučuje poranění parenchymatózních orgánů.	V NORMĚ
198	Oboustranně mnohočetné B-linie; obraz odpovídá intersticiálnímu syndromu.	NÁLEZ
199	FAST pozitivní: [V Morisonově prostoru] volná tekutina. Ošetřujícímu týmu [hodin] nahlášeno.	AKUTNÍ
200	[Vpravo/Vlevo] lung sliding nepozorován a zachycen lung point; svědčí pro pneumotorax. [Čas] nahlášeno.	AKUTNÍ

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní otevřete Bonus 2 · 50 nejčastějších chyb v popisu, které opravuje školitel. Naučili jste se vybrat správný závěr popisu; nyní poznejte chyby, kvůli kterým se popis vrací, a už je neopakujte.

Chcete-li vidět věty v kontextu celého popisu **Hlavní materiál · 120 šablon Hotový popis™** – můžete se vrátit.